



Collection MedWIZ

3^e année médecine

APPAREIL NEUROLOGIQUE- LOCOMOTEUR ET CUTANÉ

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Sémiologie :

1. Sémiologie neurologique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Examen neurologique	10				
02	Examen de la station debout et de la marche	12				
03	Examen de la motricité et des réflexes - Troubles de la motricité	14				
04	Examen de la sensibilité	16				
05	Examen des fonctions supérieures	18				
06	Algies cranio-faciales	20				
07	Troubles de l'équilibre et de la coordination	22				
08	Troubles de la sensibilité	24				
09	Nerfs I, II et VIII	26				
10	Nerfs III, IV, V, VI et VII	28				
11	Nerfs IX, X, XI et XII	30				
12	Troubles de la conscience	32				
13	Explorations en neurologie (FO, PL, EEG et EMG)	34				

2. Sémiologie dermatologique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
14	Sémiologie de l'appareil cutané	38				
15	Lésions cutanées secondaires	40				

3. Sémiologie locomotrice :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
16	Généralités rhumatologiques	44				
17	Diagnostic d'une monoarthrite	46				
18	Arthrose	48				

II. Physiopathologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
19	Œdèmes périphériques	52				
20	Hypertension intracrânienne (HTIC)	54				
21	Douleur	56				
22	Troubles acido-basiques	58				

III. Biochimie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
23	Exploration biochimique du LCR	62				
24	Enzymes sériques et tissulaires - Enzymes musculaires et marqueurs	64				

IV. Radiologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
25	Imagerie cérébrale en urgence (Urgences neurologiques traumatiques et non traumatiques)	70				
26	Imagerie ostéo-articulaire	72				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Sémiologie

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Chapitre I

© 2026 The WIZ The WIZ droits réservés.

Sémiologie Neurologique

© 2026 The Author / Tous droits réservés.

EXAMEN NEUROLOGIQUE

I. INTRODUCTION

- L'interrogatoire est essentiel : préciser le 1er symptôme, l'évolution (aggravation/régression), le caractère (permanent/intermittent)
- Objectifs : reconnaître les symptômes, les regrouper en syndromes, localiser la lésion, orienter les examens
- Examen orienté par des hypothèses, puis complété

II. SÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

A. MARCHE

- Examiner : vitesse, amplitude, régularité, orientation, demi-tour, ballant des bras
- Marche sur talons → loges antérolatérales
- Marche sur pointes → loge postérieure de jambe
- Signes évocateurs : fauchage, steppage

B. STATION DEBOUT

- Pieds joints, bras tendus, yeux ouverts puis fermés
- Observer l'axe, oscillations, déviation latérale
- Test appui monopodal et résistance aux poussées

C. FORCE MUSCULAIRE

1. Interrogatoire
 - Douleur, fatigabilité, déficit
2. Inspection
 - Amyotrophie, hypertrophie, fasciculations
3. Testing global
 - Mingazzini (MI), Barré (MI), bras tendus (MS) → attendre 10-20 s
4. Cotation (0 à 5)
 - 0 = aucune contraction
 - 3 = contre pesanteur
 - 5 = normal

D. TONUS MUSCULAIRE

- Résistance passive à la mobilisation
- Hypertonie spastique (élastique) → pyramidal
- Hypertonie rigide (plastique) → parkinsonien
- Hypotonie → périphérique, pyramidal initial, cérébelleux

E. RÉFLEXES

1. Ostéo-tendineux
 - Bicipital (C5)
 - Stylo-radial (C6)
 - Rotulien (L3-L4)
 - Achilléen (S1-S2)
2. Cutaneux
 - Plantaire : flexion normale du gros orteil ; Babinski → extension lente (pyramidal)
 - Abdominaux
 - Crémastérien (L1-L2)
 - Anal (S4-S5)
3. Faciaux
 - Nasopalpebral
 - Cornéen (V → VII)
 - Voile du palais (IX → X)

F. COORDINATION MOTRICE

- Épreuves : doigt-nez, talon-genou, Stewart-Holmes, Froment
- Associer marche et station debout

G. SENSIBILITÉ

1. Interrogatoire
 - Installation, topographie, nature, déclenchement
2. Cutanée
 - Tactile (coton), thermique (chaud/froid), douloureuse (piqûre)
3. Proprioceptive
 - Position, pallesthésie (diapason), ataxie (aggravée yeux fermés)
4. Corticale
 - Stéréognosie, graphesthésie, topoesthésie
5. Consignation
 - Consigner sur schéma corporel, comparatif D/G

H. NERFS CRANIENS

- I : olfactif
- II : optique (acuité, couleurs, champ visuel)
- III, IV, VI : oculomotricité
- V : trijumeau
- VII : facial
- VIII : vestibulo-cochléaire
- IX, X, XI : mixtes
- XII : hypoglosse

I. SPHINCTERS

1. Interrogatoire
 - Dysurie, pollakiurie, troubles érectiles, incontinence
2. Examen
 - Sensibilité périanale, réflexes crémastérien et anal

J. VIGILANCE ET FONCTIONS COGNITIVES

1. Vigilance : échelle de Glasgow
2. Langage : expression et compréhension
3. Gestes et schéma corporel : pantomimes, imitation, désignation
4. Visuo-spatial : dessin, copie, plan
5. Calcul, mémoire (MMS), praxies, jugement

III. SÉMIOLOGIE SYNDROMIQUE

Syndrome Caractéristique	Principales Manifestations
Myogène	Atteinte primitive des fibres musculaires
Myasthénique	Atteinte jonction neuromusculaire
Neurogène périphérique	Atteinte nerf périphérique
Pyramidal	Hypertonie spastique, Babinski, déficit
Extra-pyramidal	Hypertonie rigide, tremblement
Cérébelleux	Ataxie, hypotonie, dysmétrie
Vestibulaire	Vertige
Médullaire	Troubles sensitifs/moteurs segmentaires
Méningé	Céphalées, photophobie, raideur de nuque, Kernig, Brudzinski
HIC	Céphalées, vomissements, œdème papillaire
Confusionnel	Trouble de la conscience et de l'attention
Déméntiel	Détérioration cognitive globale
Frontal/Temporal/ Pariétal/Occipital	Syndromes hémisphériques localisés

Risques majeurs de l'HIC : engagement cérébral et atrophie optique par ischémie